**ASST del Lario Orientale**
Ospedale Generale di Monterosso
SC Anatomia Patologica - Dir. Dott. Ivan Locatelli

Via Leonardo da Vinci 75
24123 Bergamo
Tel. 035 2678840

# REFERTO DI ESAME ISTOLOGICO

Biopsia prostatica transperineale ecoguidata (mapping a 12 prelievi)

## DATI DEL PAZIENTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cognome e nome: | **Brambilla Ottavio** | Data di nascita: | **14/03/1956** |
| Codice fiscale: | **BRMTTV56C14A794C** | Tessera sanitaria: | **80380050592998479061** |
| Residenza: | **Via Gombito 18, Bergamo** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| N. esame: | B25.06614 | Accettato il: | 21.10.25 |
| Refertato il: | 29/10/2025 | Reparto: | u.o. Urologia |
| Prelievo: | 20-10-2025 | Richiedente: | Dott. Paolo Carminati |

Caso: B25.06614-AP

## DATI CLINICI

Pz. di aa. 69 con PSA totale 8,7 ng/mL (rapporto libero/totale 0,11) in incremento rispetto al controllo del 12 marzo 2025. RM multiparametrica: lesione PI-RADS 4 della zona periferica postero-laterale sinistra. In anamnesi ipertrofia prostatica benigna in terapia con tamsulosina 0,4 mg. Il sig. Brambilla è accompagnato dalla moglie, sig.ra Marisa Rota, che ha richiesto di essere informata dell'esito (tel. 035 4127701).

## MATERIALE INVIATO

Dodici contenitori etichettati da A a L, contenenti ciascuno un frustolo bioptico, secondo lo schema di mappatura allegato dal Dott. Carminati. Ulteriore contenitore M: prelievo mirato sulla lesione target (fusion RM/ecografia).

## DESCRIZIONE MACROSCOPICA

Tredici frustoli bioptici di colorito biancastro, di lunghezza compresa tra 0,9 e 1,7 cm, inclusi singolarmente (blocchetti A1-M1) e colorati con spugna di inchiostro per l'orientamento. Sezioni seriate a tre livelli.

## DESCRIZIONE MICROSCOPICA E SINTESI PER PRELIEVO

| Prel. | Sede | Lungh. | Esito | Score di Gleason | % neoplasia |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Base dx laterale | 14 mm | Tessuto prostatico benigno | - | - |
| B | Base dx mediale | 13 mm | Tessuto prostatico benigno | - | - |
| C | Medio dx laterale | 15 mm | Prostatite cronica focale | - | - |
| D | Medio dx mediale | 11 mm | Tessuto prostatico benigno | - | - |
| E | Apice dx | 10 mm | Tessuto prostatico benigno | - | - |
| F | Base sn laterale | 16 mm | Adenocarcinoma acinare | 3+3=6 | 15% |
| G | Base sn mediale | 14 mm | Tessuto prostatico benigno | - | - |
| H | Medio sn laterale | 17 mm | Adenocarcinoma acinare | 3+4=7 | 60% |
| I | Medio sn mediale | 12 mm | ASAP (proliferazione microacinare atipica) | - | - |
| J | Apice sn | 9 mm | Tessuto prostatico benigno | - | - |
| K | Zona transizionale dx | 13 mm | Iperplasia nodulare | - | - |
| L | Zona transizionale sn | 15 mm | Iperplasia nodulare | - | - |
| M | Target PI-RADS 4 | 17 mm | Adenocarcinoma acinare | 3+4=7 | 80% |

Nei prelievi H e M la neoplasia è costituita da ghiandole ben formate (pattern 3) con aree di ghiandole fuse e cribriformi di piccole dimensioni (pattern 4, circa il 20% della componente neoplastica). Nel prelievo H si osserva invasione perineurale. Non estensione extraprostatica nei frustoli esaminati. Assenza di carcinoma intraduttale.

## INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE

| Anticorpo | Blocchetto | Risultato | Interpretazione |
|---|---|---|---|
| p63 | I1 | negativo (focale) | Perdita delle cellule basali in alcune ghiandole |
| CK 34betaE12 | I1 | negativo | Assenza di strato basale |
| AMACR (P504S) | I1 | debolmente positivo | Reperto non conclusivo su focolaio di 3 ghiandole |

## DIAGNOSI

**Biopsie prostatiche (13 prelievi): adenocarcinoma acinare della prostata, score di Gleason 3+4=7 (Grade Group 2 ISUP), presente in 3 prelievi su 13 (lobo sinistro e target), con invasione perineurale.**
Nel prelievo I: proliferazione microacinare atipica (ASAP), si suggerisce stretto monitoraggio.

> *Il grading è espresso secondo i criteri ISUP 2019. Caso discusso in riunione di consenso con il Dott. Ivan Locatelli in data 28 ottobre 2025. Il caso sarà presentato al Gruppo Oncologico Multidisciplinare uro-oncologico.*

*Tracciabilità del campione*

| Fase | Data | Operatore |
|---|---|---|
| Prelievo bioptico | 20-10-2025 | Dott. Paolo Carminati (u.o. Urologia) |
| Accettazione | 21.10.25 | TSLB Sara Pezzotta |
| Inclusione e taglio | 22.10.25 | TSLB Luca Ghilardi |
| Refertazione | 29/10/2025 | Dott.ssa Federica Magri |

*Il Dirigente Medico*

**Dott.ssa Federica Magri**

OSP. GEN. MONTEROSSO
ANATOMIA PATOLOGICA
Dott.ssa F. Magri

Bergamo, 29 ottobre 2025

Referto online:
https://referti.asst-lario.example.it/ap/B25.06614